Boîte à outils contre le cancer v3.0

Outils

Objectif de la boîte à outils

Un ensemble de normes de collecte de données pour saisir les phénotypes associés à la recherche biomédicale liée au cancer, telles que déterminées à l'origine par le groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes H3Africa et H3AbioNet et poursuivies dans leur développement par l'African Genomics Data Hub (AfriGen-D).

Description des lignes directrices

Le kit d'outils sur le cancer est un module complémentaire qui peut être utilisé conjointement avec le kit d'outils sur les phénotypes de base afin de recueillir des phénotypes essentiels à la recherche sur le cancer, notamment : le pronostic et les antécédents de traitement du cancer, les dépistages du cancer, les antécédents familiaux de cancer et le pronostic associé à ces antécédents. Le document suivant établit des lignes directrices (particulièrement pertinentes en Afrique) sur l'utilisation du kit d'outils et la collecte de données phénotypiques et d'exposition détaillées, pertinentes et harmonisées pour la recherche.

Comme indiqué ci-dessous, la boîte à outils contre le cancer se compose de 4 instruments, numérotés de 1 à 4 :

Instrument	**Phénotypes**
1	Pronostic et antécédents de traitement du cancer
2	Dépistage du cancer
3	Antécédents familiaux de cancer
4	Antécédents familiaux de cancer et pronostic

Remarques importantes

1. Cet outil utilise une logique de branchement ; par conséquent, nous recommandons de le compléter dans l'ordre, car certaines variables peuvent apparaître ou non, ou accepter des entrées en fonction des entrées des variables précédemment listées.

2. Certaines logiques de branchement (notamment liées à la date de naissance/l'âge et au sexe biologique) affectent l'affichage des éléments pertinents pour les participants adultes ou pédiatriques dans plusieurs instruments.

3. Toute modification ou suppression de variables peut également affecter la logique de branchement ; il convient donc de positionner soigneusement la modification des variables afin de ne pas interrompre les conditions de la logique de branchement avec des variables liées.

4. Il est recommandé d'utiliser cet outil en conjonction avec l'outil Core Phenotypes (https://github.com/h3abionet/h3aphenstds).

5. Bien que cela ne soit pas indiqué ci-dessous, chaque instrument nécessite une date de prélèvement, qui peut être effectuée manuellement ou automatiquement.

6. L'utilisation de codes cohérents est recommandée pour l'identification des données manquantes, et ceux-ci sont intégrés dans tous les instruments présentés ci-dessous.

7. Les codes relatifs aux données manquantes sont spécifiés ci-dessous :

Code	Étiquette de valeur
-991	Aucune information
-992	Question posée mais inconnue
-993	Temporairement indisponible
-994	Non demandé
-995	Refusé
-998	Non applicable

8. Nous recommandons, lorsqu'un participant répond « Je ne sais pas » à une question, que l'intervieweur s'assure d'abord que le participant a bien compris la question, puis l'invite, si possible, à reconsidérer sa réponse. Si la réponse reste « Je ne sais pas », nous utilisons le code « Question posée, réponse inconnue ». Pour les questions où « Je ne sais pas » est une réponse courante et valide, une case à cocher « Inconnu » sera ajoutée ; il est important de noter que cette réponse ne sera pas considérée comme une donnée manquante par les logiciels statistiques.

9. Les traductions intégrées à partir de la version 3.0 permettent aux collecteurs de données utilisant REDCap de basculer entre les versions traduites des instruments – veuillez consulter la documentation supplémentaire sur la mise en œuvre et l'utilisation des traductions.

Recommandations

Instrument 1 : Pronostic du cancer et antécédents de traitement

Cet instrument permet de recueillir rétrospectivement les antécédents de cancer d'un participant à une recherche, c'est-à-dire un historique de ses antécédents médicaux concernant la survenue de cancers et les problèmes qui y sont liés. De plus, il permet de recueillir rétrospectivement les antécédents de traitement du cancer d'un participant, c'est-à-dire le détail des types de traitements reçus pour chaque cancer. Cet instrument est une mesure répétée qui peut être utilisée pour plusieurs diagnostics de cancers non liés entre eux.

Questions	Date du diagnostic de cancer : Âge au moment du diagnostic du cancer : Veuillez préciser le type de cancer : **Options de réponse** : Os ; Cerveau ; Sein ; Col de l'utérus ; Côlon/Rectum ; Endomètre ; Poumon ; Système lymphatique ; Ovaire ; Pancréas ; Prostate ; Peau ; Thyroïde ; Autres (Si autre) Précisez le type de cancer : Ce cancer a-t-il métastasé/s'est-il propagé à d'autres parties du corps ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez le(s) site(s) de métastase : Ce cancer a-t -il récidivé ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Précisez la date de récurrence : Précisez le stade le plus avancé du cancer : **Options de réponse** : Étape 1 ; Étape 2 ; Étape 3 ; Étape 4 Précisez l'issue du cancer : **Options de réponse** : Toujours actif ; En rémission ; Guéri
Notes	- La série de questions ci-dessus peut être répétée en fonction du nombre de diagnostics de cancer non liés rapportés dans les phénotypes de base. - Le terme « cancers non liés » désigne la survenue de cancers indépendants. Il ne s'agit pas d'un cancer qui s'est propagé d'un site à un autre (métastase) ni d'une récidive d'un cancer en rémission. - **Le type de cancer** fait référence à l'organe ou au site spécifique touché par la maladie. - **La stadification du cancer** est le processus permettant de déterminer son degré de développement, notamment sa croissance et sa propagation. Au stade I, la tumeur est petite et localisée. Aux stades 2 et 3, elle est plus étendue et a envahi les tissus voisins. Au stade 4, elle s'est propagée à d'autres parties du corps.

	- **La récidive du cancer** survient lorsque le cancer réapparaît après un traitement. Cela peut se produire des semaines, des mois, voire des années après le traitement du cancer primitif ou initial. - **Les métastases cancéreuses** signifient que le cancer se propage à une partie du corps différente de celle où il a débuté.
Questions	Le participant a-t-il subi une intervention chirurgicale pour ce cancer ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Combien d'opérations chirurgicales ? (Si oui) Précisez la ou les interventions chirurgicales :
Notes	- La chirurgie oncologique peut être pratiquée pour diverses raisons, notamment à visée curative, préventive, diagnostique, de stadification, de réduction tumorale, palliative, de soutien et réparatrice. Toutes ces interventions doivent être déclarées ici. - Les interventions chirurgicales courantes pour traiter le cancer comprennent la craniotomie (cerveau), la gastrectomie (estomac), l'hystérectomie (col de l'utérus, ovaires, utérus), la mastectomie (sein), la prostatectomie (prostate) et la thyroïdectomie (thyroïde). - Les noms des interventions chirurgicales peuvent être extraits des dossiers hospitaliers, s'ils sont disponibles et avec le consentement éclairé du patient. S'ils sont déclarés par le patient lui-même, les noms des interventions peuvent également être consignés en termes simples.
Questions	Le participant a-t-il reçu une chimiothérapie pour ce cancer ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Je ne sais pas Date d'achèvement : Le participant a-t-il reçu une radiothérapie pour ce cancer ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Je ne sais pas Date d'achèvement : La participante a-t-elle reçu une hormonothérapie pour ce cancer ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Je ne sais pas Date d'achèvement : Le participant a-t-il reçu d'autres types de thérapie ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si oui) Veuillez préciser le ou les types de thérapie reçus : Date d'achèvement :
Notes	- Les dates doivent être recueillies au format suivant : JJ-MM-AAAA - **La chimiothérapie** est une forme agressive de traitement médicamenteux chimique utilisée pour soigner le cancer. Ce traitement est dit systémique, car le médicament se diffuse dans tout l'organisme. **Méthodes d'administration des médicaments de chimiothérapie** Elles comprennent : les voies d'administration orale, par perfusion, par injection, par voie topique, par voie intrathécale et par voie intrapéritonéale. - **La radiothérapie** consiste à utiliser des rayonnements de haute énergie provenant de rayons X, de rayons gamma, de neutrons, de protons et d'autres sources pour

	tuer les cellules cancéreuses, réduire les tumeurs et/ou atténuer certains symptômes liés au cancer. - **L'hormonothérapie** est utilisée pour traiter les cancers qui se développent grâce aux hormones, comme certains cancers de la prostate et du sein. Ces traitements empêchent les hormones de se fixer à leurs récepteurs hormonaux respectifs. - **quelques exemples** d'autres types de thérapie : **Thérapie ciblée** – utilise des médicaments ou d'autres substances pour identifier et attaquer des types spécifiques de cellules cancéreuses, en causant moins de dommages aux cellules normales. **Immunothérapie** – utilise des substances pour stimuler ou supprimer le système immunitaire afin d'aider l'organisme à lutter contre le cancer.

Instrument 2 : Dépistage du cancer

Cet instrument permet la collecte rétrospective d'informations relatives aux dépistages du cancer subis par un participant à la recherche au cours des trois dernières années. Les tests de dépistage servent à identifier certains types de cancer avant l'apparition de tout signe ou symptôme.

Questions	Avez-vous passé une radiographie pulmonaire au cours des trois dernières années ? Avez-vous subi un test de dépistage du sang dans les selles au cours des trois dernières années ? Au cours des trois dernières années, avez-vous subi une coloscopie, une sigmoïdoscopie ou un lavement baryté pour examiner votre côlon et votre rectum ? Avez-vous passé une mammographie au cours des trois dernières années ? Avez-vous subi un test sanguin pour le cancer du foie au cours des trois dernières années ? **Options de réponse** : Non ; Oui, une fois ; Oui, plus d'une fois ;
Notes	- Une **radiographie thoracique** est une radiographie des structures à l'intérieur de la poitrine, utilisée pour diagnostiquer des maladies (principalement le cancer du poumon). - La recherche de sang dans les selles est un test fécal réalisé pour dépister le cancer colorectal ou les polypes colorectaux. - Une **coloscopie et une sigmoïdoscopie** est un type d'examen au cours duquel un long tube flexible (colonoscope) ou un tube fin et flexible (sigmoïdoscope) est inséré dans le rectum avec une caméra qui permet au médecin de visualiser l'intérieur de tout le côlon. - Une **mammographie** est une radiographie utilisée pour examiner le tissu mammaire et identifier le cancer du sein.
Questions	[(SI FEMME) Au cours des trois dernières années, avez-vous subi un frottis cervico-vaginal ? (SI VOUS ÊTES UNE FEMME) Avez-vous subi un examen pelvien au cours des trois dernières années ?

	(SI VOUS ÊTES UNE FEMME) Avez-vous subi une échographie ou un examen des ovaires au cours des trois dernières années ? (SI VOUS ÊTES UNE FEMME) Au cours des trois dernières années, avez-vous subi un test sanguin pour le dépistage du cancer de l'ovaire, par exemple le dosage du CA-125 ? **Options de réponse** : Non ; Oui, une fois ; Oui, plus d'une fois ;
Notes	- Un **test Pap** consiste à prélever et à examiner des cellules du col de l'utérus — la partie inférieure et étroite de l'utérus qui se trouve en haut du vagin. - Un **examen pelvien** est un examen visuel et physique des organes reproducteurs d'une femme effectué par un médecin. - Une **échographie** est une procédure qui utilise des ondes sonores à haute fréquence pour créer une image d'une partie de l'intérieur de votre corps.
Question	[(SI HOMME) Au cours des trois dernières années, avez-vous subi un toucher rectal de la prostate ? (SI HOMME) Avez-vous subi un test sanguin pour le dépistage du cancer de la prostate au cours des trois dernières années, par exemple un dosage du PSA ? **Options de réponse** : Non ; Oui, une fois ; Oui, plus d' une fois ; Un test génétique pour le cancer/la prédisposition au cancer ? **Options de réponse** : Oui ; Non
Notes	- Le **toucher rectal** est un examen qui permet d'explorer le bas du rectum, le bassin et le bas-ventre d'une personne, et qui est couramment utilisé pour diagnostiquer le cancer de la prostate chez les hommes.

Instrument 3 : Antécédents familiaux de cancer

L'instrument recueille simplement le nombre de membres de la famille qui ont eu un cancer et est distinct de l'instrument de détails sur les antécédents familiaux de cancer qui suit afin de permettre de multiples itérations des détails par membre touché sur l'instrument suivant, qui peut être répété autant de fois que nécessaire.

Questions	ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX DE CANCER - APERÇU Combien de membres de ma famille nucléaire ont eu un cancer ? Combien de membres de votre famille élargie ont eu un cancer ?
Notes	- **de la famille nucléaire** sont les membres de la famille biologique qui vivent sous le même toit, y compris les parents et les enfants/frères et sœurs. - **de la famille élargie** sont les membres de la famille biologique qui ne vivent pas sous le même toit que le foyer, y compris les oncles, les tantes, les cousins, les neveux et les nièces.

Instrument 4 : Pronostic des antécédents familiaux de cancer

Cet outil permet de recueillir les antécédents de diagnostic de cancer dans la famille du participant. Il permet également d'obtenir des informations détaillées sur les membres de la famille touchés, telles que le sexe, le type de cancer, l'âge au premier diagnostic et tout autre diagnostic de cancer, fournissant ainsi des renseignements supplémentaires sur la possibilité d'une transmission héréditaire. Hormis la section de synthèse, l'outil peut être utilisé à plusieurs reprises pour recueillir des informations détaillées sur les membres de la famille ayant reçu un diagnostic de cancer.

Questions	ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX DE CANCER - APERÇU Combien de membres de ma famille nucléaire ont eu un cancer ? Combien de membres de votre famille élargie ont eu un cancer ?
Notes	- **de la famille nucléaire** sont les membres de la famille biologique qui vivent sous le même toit, y compris les parents et les enfants/frères et sœurs. - **de la famille élargie** sont les membres de la famille biologique qui ne vivent pas sous le même toit que le foyer, y compris les oncles, les tantes, les cousins, les neveux et les nièces.
Questions	ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX DE CANCER - PRONOSTIC Quel est/était le sexe biologique du parent ? **Options de réponse** : Homme ; Femme ; Autre Le parent est-il vivant ? **Options de réponse** : Oui ; Non Quel est l'âge actuel du proche ou son âge au décès ? **Options de réponse** : < 40 ans ; 40-50 ans ; 51-64 ans ; 65 ans et plus Précisez le premier diagnostic de cancer du proche : **Options de réponse** : Os ; Cerveau ; Sein ; Col de l'utérus ; Côlon/Rectum ; Endomètre ; Poumon ; Système lymphatique ; Ovaire ; Pancréas ; Prostate ; Peau ; Thyroïde ; Autres (Si autre) Précisez le premier diagnostic de cancer du proche : Quel était leur âge lors du premier diagnostic de cancer ? **Options de réponse** : < 40 ans ; 40-50 ans ; 51-64 ans ; 65 ans et plus Le proche a-t-il ensuite développé un cancer ? **Options de réponse** : Oui ; Non (Si OUI) Quel a été leur diagnostic de cancer ultérieur ? **Options de réponse** : Os ; Cerveau ; Sein ; Col de l'utérus ; Côlon/Rectum ; Endomètre ; Poumon ; Système lymphatique ; Ovaire ; Pancréas ; Prostate ; Peau ; Thyroïde ; Autres (Si autre) Précisez le diagnostic ultérieur du proche :
Notes	- Cette section peut être répétée afin de recueillir des informations détaillées sur chaque membre de la famille ayant reçu un diagnostic de cancer. - **Un diagnostic de cancer ultérieur** désigne un diagnostic de cancer sans lien avec le cancer initial (c'est-à-dire une récidive).

Abréviations

CA-125 : Antigène tumoral 125
PSA : Antigène spécifique de la prostate

Administration

Mode d'administration

	Instruments		
	1	2	3
Entretien OU questionnaire auto-administré	X	X	X
évaluation clinique			
Évaluation par bioessai/en laboratoire			

Étape de la vie

	Instruments		
	1	2	3
Nourrisson (0 - 12 mois)	X		X
Enfant en bas âge (13 à 24 mois)	X		X
Enfance (2-11 ans)	X	X	X
Adolescence (12 - 18 ans)	X	X	X
Adulte (18 ans et plus)	X	X	X

Personnel et formation requis

Tous les instruments peuvent être utilisés sous forme de questionnaires auto-administrés ou de questionnaires administrés par un enquêteur (recommandé). Dans ce dernier cas, les entretiens doivent être menés par des coordinateurs d'étude ou des enquêteurs formés et maîtrisant la langue maternelle/locale de la population cible. Si disponibles, **les instruments 1 à 3** peuvent être enregistrés à partir des dossiers hospitaliers et/ou des dossiers des patients ou vérifiés par recoupement avec ceux-ci.

Références

La boîte à outils sur le cancer s'appuie sur plusieurs normes existantes et s'y conforme afin de faciliter l'harmonisation des données . Ces ressources sont énumérées ci-dessous :

1. Instrument - Cancer : Antécédents personnels et familiaux (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/70601)
2. Instrument - Traitements contre le cancer (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/71101)
3. Instrument - Dépistage du cancer (https://www.phenxtoolkit.org/protocols/view/70901)

Contributeurs

Après 2024
Projet AfriGen -D CRF Stds et REDCap

Avant 2024
sur l'harmonisation des phénotypes - H3Afrique
conjoint d'harmonisation des phénotypes - H3ABioNet
de standardisation des phénotypes - H3ABioNet
Chaimae Samtal
Dassen Sathan
Faisal Fadlelmola
Yosr Hamdi

Contactez-nous

Pour toute question relative à cette norme et à ces lignes directrices, les utilisateurs peuvent ouvrir un ticket auprès du service d'assistance AfriGen -D (Data Collection Toolkits). Vos commentaires et suggestions d'amélioration concernant le kit d'outils actuel sont les bienvenus. Vous pouvez les soumettre via le service d'assistance ou sur les sections « Problèmes » et « Discussion » de notre dépôt GitHub .